

CIVD — TRATAR CAUSA + SUPORTE

DIAGNÓSTICO — ESCORE ISTH

Exame	Resultado	Pontuação ISTH
Plaquetas	>100k 50-100k <50k	0 1 2
D-dímero / produtos de fibrina	Não elevado elevado moderado muito elevado	0 2 3
Tempo de protrombina (TP)	<3s prolongado 3-6s >6s	0 1 2
Fibrinogênio	>1 g/L ≤1 g/L	0 1
Escore ≥5 = CIVD manifesta	Escore 4 = CIVD suspeita	Escore <4 = não sugere CIVD

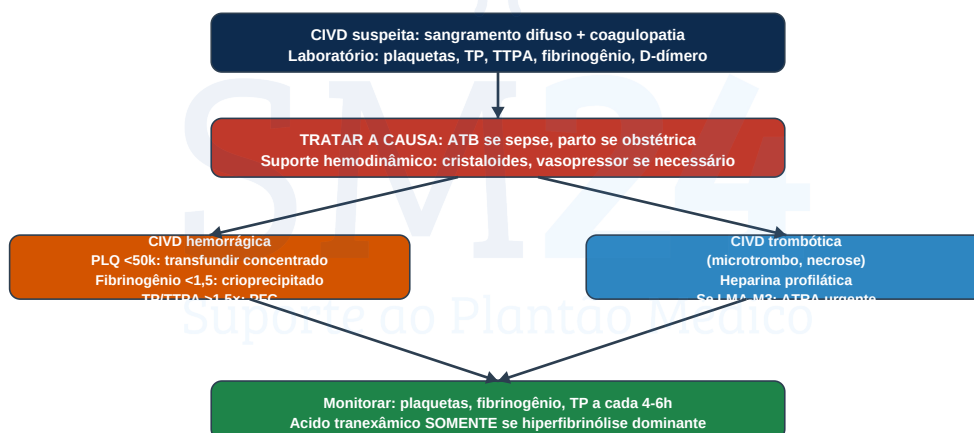
CAUSAS DE CIVD

CIVD É SEMPRE SECUNDÁRIA A UMA CAUSA

- Sepses/choque séptico — causa mais comum (especialmente Gram-negativos)
- Trauma grave / TCE com exposição de tecido cerebral rico em fator tissular
- Neoplasias: leucemia promielocítica aguda (LMA-M3), adenocarcinomas
- Complicações obstétricas: DPPNI, embolia por líquido amniótico, retenção de feto morto
- Transfusão incompatível, hemólise maciça
- Mordida de cobra (peçonha com atividade pró-coagulante)

MANEJO DA CIVD

CIVD — CAUSA + SUPORTE HEMOSTÁTICO



TRANSFUSÃO NA CIVD — LIMIARES

Componente	Indicação	Dose
Concentrado de plaquetas (CP)	Sangrando com PLQ <50k OU assintomático com PLQ <20k	1 CP por 10 kg (adulto: 4-6 unidades)
Plasma fresco congelado (PFC)	TP ou TTPA >1,5× VN + sangramento	10-15 mL/kg (3-4 unidades)
Crioprecipitado	Fibrinogênio <1,5 g/L + sangramento ativo	1-1,5 unidades/10 kg (10 unidades)
Concentrado de hemácias	Hb <7 g/dL (8 se coronariopata, sintomático)	1 unidade → esperar Hb antes de repetir
Vitamina K	Se TP prolongado por deficiência (hepatopatia)	10 mg IV em 20 min
Ácido tranexâmico	SOMENTE hiperfibrinólise documentada (trauma, pós-parto)	1 g IV em 10 min dentro de 3h do evento

LMA-M3 E CIVD — URGÊNCIA ONCOLÓGICA

LPA (Leucemia Promielocítica)

- LMA-M3: risco de CIVD fatal por grânulos promielocíticos
- Diagnóstico: esfregaço + PML-RAR α (t15;17)
- ATRA (ácido all-trans-retinóico) 45 mg/m²/d — URGENTE
- ATRA inicia hiperfibrinólise antes de melhorar — suporte hemostático intensivo
- Fibrinogênio: manter >1,5 g/L com crioprecipitado
- Plaquetas: manter >50k durante indução

Monitoramento e Prognóstico

- Mortalidade da CIVD grave: 40-80% (depende da causa)
- Melhor prognóstico: obstétrica (causa removível); pior: sepse grave
- Colher: fibrinogênio, D-dímero, TP, TTPA, plaquetas a cada 4-6h
- Gasometria + lactato: perfusão tissular (microtrombo)
- Sem papel para heparina em doses plenas na CIVD hemorrágica
- Profilaxia de TVP: heparina subcutânea quando sangramento controlado

CIVD — PONTOS-CHAVE

NÃO ESQUECER

- ☐ CIVD é SEMPRE secundária — tratar a causa é o pilar do tratamento
- ☐ Escore ISTH $\geq$ 5: CIVD manifesta; repetir a cada 4-6h para monitorar
- ☐ D-dímero alto + plaquetas baixas + fibrinogênio baixo = tríade da CIVD
- ☐ NÃO transfundir profilaticamente sem sangramento ativo (exceto PLQ <20k)
- ☐ LMA-M3: iniciar ATRA imediatamente — não esperar mielograma
- ☐ Ácido tranexâmico: apenas hiperfibrinólise dominante (não usar em CIVD trombótica)

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente séptico com PLQ 45k, fibrinogênio 0,8 g/L, TP alargado 2× e D-dímero muito elevado. Qual é o escore ISTH e a conduta?

- A) Escore 4 — aguardar evolução sem intervenção
- B) Escore 6 — CIVD manifesta; tratar sepse + transfundir crioprecipitado + PFC + concentrado de plaquetas
- C) Escore 3 — apenas monitorar
- D) Não é CIVD — pedir biópsia de medula óssea
- E) Escore 5 — apenas antibiótico, sem transfusão

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

A causa mais comum de CIVD no adulto hospitalizado é:

- A) Leucemia promielocítica aguda
- B) Transfusão incompatível
- C) Sepse / choque séptico
- D) Eclâmpsia grave
- E) Trauma hepático contuso

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente com CIVD hemorrágica ativa. Qual componente deve ser transfundido prioritariamente para repor fibrinogênio?

- A) Plasma fresco congelado (PFC)
- B) Concentrado de plaquetas
- C) Crioprecipitado
- D) Albumina 20%
- E) Vitamina K IV

QUESTÃO 4

SES-RJ / Adaptada

Jovem com blastos no sangue periférico, leucócitos 80k, CIVD com sangramento oral. Qual diagnóstico deve ser investigado e qual a conduta imediata?

- A) LMA-M3 (promielocítica) — ATRA imediato + suporte hemostático intensivo
- B) LMC — iniciar imatinibe
- C) Linfoma difuso — biópsia linfonodal urgente
- D) Aplasia medular — transfusão e ciclosporina
- E) Sepse fúngica — anfotericina B IV

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Por que o ácido tranexâmico (antifibrinolítico) é contraindicado na maioria dos casos de CIVD?

- A) Porque é caro e não há evidência de benefício
- B) Porque a CIVD geralmente tem componente trombótico — inibir fibrinólise agrava microtrombo e falência orgânica
- C) Porque causa hemólise em pacientes sépticos
- D) Porque prolonga o TP e o TTPA
- E) Porque interage com heparina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Escore ISTH: PLQ 45k (2) + fibrinogênio ≤ 1 g/L (1) + TP > 6 s alargado $\approx$ se $> 1,5\times = 2$ + D-dímero muito elevado (3) = 8 → CIVD manifesta. Conduta: tratar sepse (ATB urgente) + crioprecipitado (fibrinogênio $< 1,5$) + PFC (TP $> 1,5\times$) + PLQ se < 50 k com sangramento.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Sepse é a causa mais comum de CIVD no adulto, especialmente por Gram-negativos (LPS ativa fator tissular). Outras causas importantes: trauma grave, LMA-M3, complicações obstétricas. Tratar a causa de base é o pilar.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Crioprecipitado = fonte concentrada de fibrinogênio (fator I), fator VIII, fator von Willebrand e fator XIII. Indicado quando fibrinogênio $< 1,5$ g/L com sangramento. PFC contém todos os fatores, mas em baixa concentração — menos eficiente para repor fibrinogênio isolado.

QUESTÃO 4 → Resposta: A

LMA-M3 (leucemia promielocítica aguda): t(15;17), PML-RAR α . Os grânulos azurófilos dos promielócitos contêm substâncias pró-coagulantes e fibrinolíticas → CIVD fatal. ATRA (ácido all-trans-retinóico) é urgente — diferencia os blastos e controla a CIVD progressivamente.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

CIVD é um processo simultâneo de coagulação excessiva (formação de microtrombos) e fibrinólise reativa. Inibir a fibrinólise (ácido tranexâmico) sem controlar a coagulação acelera a deposição de fibrina nos microvasos → falência orgânica. Usar apenas se hiperfibrinólise dominante (ex: LMA-M3, trauma).

SM24
Suporte ao Plantão Médico